

Nomor : B/4372/112024
Lampiran : 1 berkas

11 November 2024

Yth.
Pimpinan PLKK Rumah Sakit
di
Tempat

Perihal : Perpanjangan Perjanjian Kerjasama PLKK BPJS Ketenagakerjaan
Malang

Dengan hormat,

Terimakasih atas kerjasama yang terjalin dengan baik selama ini dalam melayani peserta BPJS Ketenagakerjaan, semoga Bapak/Ibu selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan.

Dalam rangka Perpanjangan Kerjasama PLKK adapun yang perlu dipersiapkan antara lain :

1. Melakukan self assesement kredensialing sesuai dengan format terlampir paling lambat hari Senin tanggal 18 November 2024.
2. Mengirimkan surat permohonan perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) paling lambat hari Senin tanggal 18 November 2024.

Bagi Bapak/Ibu yang sudah melakukan self assesement kredensialing dapat mengirimkan berkas dalam bentuk PDF ke alamat email lora.srinovita@bpjsketenagakerjaan.go.id; mardliyatus.sholihah@bpjsketenagakerjaan.go.id; riessa.roseline@bpjsketenagakerjaan.go.id. Jika diperlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi BPJS Ketenagakerjaan atas nama sdr Lora Sri Novita (082163804620); Mardliyatus Sholihah (081333056900); Riessa Roseline (085755283331).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama diucapkan terimakasih.



Widodo
Kepala Kantor Cabang Kelas 2 Malang

ER/MA/JM 00.01

Formulir Penilaian Kredensial PLKK - Tingkat Pratama

A. Identitas

- | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| 1 Nama | : | | |
| 2 Alamat | : | | |
| | : | | |
| 3 Kode Pos | : | | |
| 4 Nomor Telepon | : | | |
| 5 Alamat e-mail | : | | |
| 6 NPWP | : | | |
| 7 Jenis | : | ☐ | Klinik |
| | : | ☐ | Pusat kesehatan masyarakat |
| | : | ☐ | Praktik dokter bersama |
| 8 Status Kepemilikan | : | ☐ | Pemerintah |
| | : | ☐ | Swasta |
| | : | ☐ | TNI/Polisi |

B. Identitas Pemilik

- 1 Nama Pemilik/Pimpinan :
2 Nomor Telepon/Handphone :
3 Alamat e-mail :

PERSYARATAN KERJA SAMA

1	Surat Izin Operasional	:	☐ Ya	☐ Tidak
2	Surat Izin Praktik (SIP)	:	☐ Ya	☐ Tidak
3	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan	:	☐ Ya	☐ Tidak
4	Pekerja terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan	:	☐ Ya	☐ Tidak

PENILAIAN KREDENSIAL

A. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

No	Kategori	Pemantauan	Skor	Nilai
Tenaga kesehatan				
1	Dokter umum	☐ 1	0	
		☐ > 1	1	
2	Dokter spesialis	☐ Tidak	0	
		☐ Ada	2	
3	Apoteker	☐ Tidak	0	
		☐ Ada	1	
4	Perawat	☐ Tidak	0	
		☐ Ada	1	
Tenaga lainnya				
1	Tenaga administrasi	☐ Tidak	0	
		☐ Ya	1	
2	Tenaga keamanan	☐ Tidak	0	
		☐ Ya	1	
3	Tenaga kebersihan	☐ Tidak	0	
		☐ Ya	1	
Nilai Aspek (a)				0

B. ASPEK SARANA DAN PRASARANA

No	Kategori	Pemantauan		Skor	Nilai
Bangunan					
1	Kepemilikan	☐	Sewa/Pinjam Pakai	0	
		☐	Milik	1	
2	Berada di jalan utama	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	1	
3	Akses jalan	☐	Satu arah	0	
		☐	Dua arah	1	
4	Dilewati kendaraan umum	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	1	
5	Tempat parkir	☐	Tidak ada	0	
		☐	Ada untuk kendaraan roda dua	1	
		☐	Ada untuk kendaraan roda empat	1	
		☐	Ada untuk kendaraan roda dua dan empat	2	
6	Sarana air bersih	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	1	
7	Genset	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	1	
Ruangan					
1	Ruang pendaftaran	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	1	
2	Ruang pemeriksaan umum	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	2	
3	Ruang tindakan	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	2	
4	Ruang rawat inap	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	1	
5	Ruang apotek/farmasi	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	1	
6	Ruang adminitrasi dan manajemen	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	1	
7	Toilet pasien	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	1	
Prasarana di ruang tunggu					
1	Dispenser/air mineral	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	1	
2	Pendingin ruangan	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	1	
3	Tempat sampah	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	1	
4	Televisi	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	1	

5	Koran dan/atau majalah	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	1	
6	Sistem antrian	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	1	
7	Sistem kepuasan pelayanan	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	1	
8	Jaringan internet (WIFI)	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	1	
9	Kursi Tunggu	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	1	
10	Tempat Penyimpanan Rekam Medis	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	1	
11	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	1	
Nilai Aspek (b)					0

C. ASPEK LAINNYA

C. ASPEK LAINNYA					
1	Standar pelayanan	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	2	
2	Prosedur administrasi dan pelaporan	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	2	
3	Kesediaan menggunakan aplikasi PLKK	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	2	
4	Kesediaan memasang logo PLKK dan media informasi	☐	Tidak	0	
		☐	Ya	2	
5	Jumlah hari operasional	☐	< 6 hari seminggu	1	
		☐	6 - 7 hari seminggu	2	
6	Jam operasional	☐	< 12 jam per hari	1	
		☐	12 - 24 jam per hari	2	
Nilai Aspek (c)					0

No	Nilai Aspek	Total Nilai	Bobot	Nilai Akhir
(p)	(q)	(r)	(s)	(t) = (r) x (s)
1	a	0	4	0
2	b	0	3	0
3	c	0	2	0
Total Nilai Akhir				0

Nilai Kredensial = (Total Nilai Akhir/140) * 100%	0%
---	----

No	NILAI KREDENSIALING	KRITERIA
1	> 75%	A
2	50% - 75%	B
3	< 50%	C

Malang, 2024

Tim Penilai

(Lora Sri Novita)
Manajer Kasus KK-PAK

(Erwin Setiawan)
Kabid. Pelayanan

Menyetujui,

(Widodo)
Kepala

LOGO PIHAK
KEDUA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG -----
DENGAN
(NAMA PLKK RS)
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA**

Nomor: PER/ ... /.... (nomor pihak pertama)

Nomor: (nomor pihak kedua)

Pada hari ini ... (nama hari) tanggal ... (00-00-0000) di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

I. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang ----- : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh ... (Nama Kepala Kantor Cabang) dalam jabatannya selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang ...(nama kantor cabang) Berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: ... (nomor kep) tentang ... (judul kep) dan Surat Kuasa Khusus Nomor: ... (nomor surat kuasa) tanggal ... (tanggal surat kuasa), dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang ...(nama kantor cabang) yang berkedudukan di ... (alamat kantor cabang), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II (NAMA RUMAH SAKIT) : Suatu ... (sesuai bentuk faskes contoh: PT...../BLUD.....) yang didirikan berdasarkan (Contoh Akta Pendirian apabila PT, Pergub/Perbub, apabila BLUD dll) dalam hal ini diwakili oleh ... (Nama penandatangan pihak kedua yang berwenang) selaku ... (Nama Jabatan) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan ... (Contoh: Dasar Kewenangan antara lain: Akta Pendirian Perusahaan, Surat Keputusan, Surat Kuasa dsb..... Nomor... Tanggal ...), dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama ... (nama rumah sakit) yang berkedudukan di Jalan ... (alamat pihak

kedua) selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah rumah sakit ... (sesuai dengan bentuk Rumah Sakit contoh Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta dsb) yang didirikan berdasarkan (Contoh Akta Pendirian apabila PT, Pergub/Perbub, apabila BLUD dll).
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah membuat perjanjian kerja sama nomor:.... nomor... tentang Yang akan berakhir pada tanggal ...;
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerja sama nomor:....(nomor **PIHAK PERTAMA**) nomor:....(nomor **PIHAK KEDUA**) tentang dan membuat perjanjian kerja sama yang baru untuk memberikan pelayanan kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di **PIHAK KEDUA** bagi peserta **PIHAK PERTAMA** yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja yang lebih optimal.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
3. Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disingkat PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
5. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah identitas sebagai bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada Peserta yang

mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif.

7. *Trauma Center* BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pusat Layanan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat PLKK adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa klinik, puskesmas, balai pengobatan, praktek dokter bersama dan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Kerja dan/atau PAK.
8. Eligibilitas adalah kelayakan peserta untuk mendapatkan manfaat Pelayanan Kesehatan akibat Kecelakaan Kerja dan/atau PAK.
9. Surat Kelayakan Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat program JKK.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran administrasi klaim dan Pelayanan Kesehatan yang telah dilaksanakan oleh PLKK.
11. Aplikasi PLKK selanjutnya disebut Aplikasi e-PLKK adalah sistem informasi yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk digunakan PLKK dalam menjalankannya.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan layanan kesehatan bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan layanan kesehatan bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemberian Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Program JKK;
- b. Tarif Pelayanan Kesehatan;
- c. tata cara pengajuan dan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan; dan
- d. kadaluarsa pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan Pelayanan Kesehatan berdasarkan prosedur Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis Peserta.
- (2) Prosedur Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran I Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
TARIF PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta dibayarkan sesuai Tarif yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tarif yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yaitu ... (pilih salah satu: 1. Tarif INA-CBGs yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau 2. Tarif paket tindakan atau 3. Tarif Fee for services yang setara tarif kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah.... (nama) atau tarif Rumah Sakit Pemerintah Daerah...(nama) di Provinsi setempat).
- (3) Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran II Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. (rincian tarif mengikuti tarif yang disepakati pada ayat 2).

PASAL 6
TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TAGIHAN
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan bulan berjalan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan 1 (satu) kali secara kolektif paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka pengajuan tagihan dari **PIHAK KEDUA** dilakukan paling lambat pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan pengecekan kelengkapan berkas dokumen pengajuan tagihan biaya pelayanan kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan tagihan biaya pelayanan kesehatan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal dokumen tidak lengkap, **PIHAK PERTAMA** menginformasikan dan mengembalikan berkas dokumen pengajuan tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilengkapi dan ditagihkan kembali pada penagihan bulan berikutnya dengan ketentuan tidak melewati kadaluarsa klaim.
- (5) Dalam hal dokumen lengkap, **PIHAK PERTAMA** menyampaikan informasi kelengkapan dokumen kepada **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK PERTAMA** melakukan Verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dengan ketentuan:
 - a. dalam hal hasil Verifikasi **PIHAK PERTAMA** menyatakan dokumen telah sesuai dan benar maka pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen terverifikasi dibuktikan dengan lembar hasil verifikasi.
 - b. dalam hal hasil Verifikasi menyatakan dokumen tidak sesuai dan/atau tidak benar maka **PIHAK PERTAMA** menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penyesuaian dokumen tagihan.
 - c. penyesuaian dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kembali oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) hari kerja.
 - d. dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melakukan penyesuaian dan tidak menyampaikan kembali dokumen tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud

huruf c maka **PIHAK PERTAMA** mengembalikan dokumen tagihan kepada **PIHAK KEDUA**.

- e. dokumen tagihan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diajukan kembali bersamaan dengan pengajuan tagihan biaya pelayanan kesehatan pada bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Bentuk dokumen penyampaian informasi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (8) Dalam hal batas waktu pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (9) Tata cara pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan secara rinci diatur dalam Lampiran III Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 KADALUARSA KLAIM

- (1) Masa kadaluarsa pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak Pelayanan Kesehatan selesai diberikan.
- (2) Masa kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pengajuan tagihan sebagai berikut:
 - a. biaya Pelayanan Kesehatan yang belum ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. biaya Pelayanan Kesehatan yang telah ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, namun dokumen belum lengkap dan tidak ditagihkan kembali kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
 - c. biaya Pelayanan Kesehatan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil Verifikasi **PIHAK PERTAMA** dan tidak ditagihkan kembali ke **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. mendapatkan kepastian Pelayanan Kesehatan sesuai standar Pelayanan Kesehatan yang berlaku bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK;
 - b. Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK mendapatkan fasilitas rawat inap pada ruang perawatan kelas ... **(bagi rumah sakit pemerintah kelas 1 dan bagi rumah sakit swasta setara rumah sakit pemerintah kelas 1 provinsi setempat sebagaimana pasal 5 ayat 2)**;
 - c. mendapatkan data dan informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta, termasuk rekam medis yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan kredensialing kepada **PIHAK KEDUA** yang meliputi aspek legalitas, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;

- e. auditor **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan audit terhadap biaya pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** atas tindak lanjut adanya kegiatan pemeriksaan di **PIHAK PERTAMA**;
- f. melakukan pemeriksaan atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan tindakan medis telah sesuai dengan panduan praktik klinis Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK.
- g. melakukan Verifikasi terhadap tagihan biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- h. mendapatkan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan rincian kasus Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dari **PIHAK KEDUA** yang dilakukan 1 (satu) kali secara kolektif dari **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- i. menerima pengembalian atas kelebihan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal **PIHAK PERTAMA** dan/atau Verifikasi pasca klaim yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- j. memberikan teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA** jika **PIHAK KEDUA** terlambat mengajukan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan/atau melanggar/tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama; dan
- k. menerima pakta integritas terkait komitmen untuk tidak menyalahgunakan dan menjaga kerahasiaan data Peserta pada Aplikasi e-PLKK, sebagaimana bentuk pakta integritas yang tercantum dalam **Lampiran IV** Perjanjian Kerja Sama ini.

Commented [1]: Di urutkan susunan lampiran dengan pasal selanjutnya

- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. menyediakan Aplikasi e-PLKK untuk kemudahan pelaksanaan kerja sama;
 - b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan daftar PLKK rujukan yang telah bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**;
 - d. melakukan pengecekan kelengkapan berkas dokumen tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan menyampaikan informasi terkait kelengkapan berkas dokumen dimaksud;
 - e. melakukan Verifikasi atas tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap, dibuktikan dengan dokumen informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7);
 - f. melakukan pembayaran atas tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen lengkap dan benar dibuktikan dengan lembar hasil verifikasi; dan
 - g. membayarkan kekurangan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadi kekurangan bayar berdasarkan hasil audit oleh pihak eksternal maupun internal **PIHAK PERTAMA** dan/atau Verifikasi pasca klaim oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - a. mengakses Aplikasi e-PLKK yang disediakan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari **PIHAK PERTAMA** bagi petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;

- c. memperoleh daftar PLKK rujukan yang telah bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**;
 - d. melakukan pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - e. menerima pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen tagihan biaya Pelayanan Kesehatan diterima lengkap dan dinyatakan benar berdasarkan Verifikasi oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - f. meminta penjelasan kepada **PIHAK PERTAMA** perihal hasil Verifikasi dan pembayaran;
 - g. menerima kekurangan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadi kekurangan bayar berdasarkan hasil audit oleh pihak eksternal maupun internal **PIHAK PERTAMA** dan atau Verifikasi pasca klaim oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - h. memberikan teguran tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** atas keterlambatan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan; dan
 - i. mendapatkan informasi lembar hasil Verifikasi.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
- a. memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta sesuai standar Pelayanan Kesehatan yang berlaku;
 - b. menyediakan fasilitas rawat inap pada ruang perawatan kelas ... (bagi rumah sakit pemerintah kelas 1 dan bagi rumah sakit swasta setara rumah sakit pemerintah kelas 1 provinsi setempat sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2) bagi peserta **PIHAK PERTAMA** yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK;
 - c. mengajukan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan memberikan laporan rincian kasus Kecelakaan Kerja dan/atau PAK yang dilakukan 1 (satu) kali secara kolektif kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - d. menyediakan data dan informasi untuk **PIHAK PERTAMA** terkait Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta, termasuk rekam medis yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyediakan data dan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait aspek legalitas, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
 - f. mengembalikan kelebihan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan sebagai tindak lanjut audit yang dilakukan pada **PIHAK PERTAMA** oleh auditor internal **PIHAK PERTAMA** maupun auditor eksternal sesuai ketentuan perundangan;
 - g. menyampaikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** perihal Kecelakaan Kerja dan/atau PAK Peserta yang sedang dilakukan perawatan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - h. menggunakan Aplikasi e-PLKK yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - i. memberikan pakta integritas terkait komitmen untuk tidak menyalahgunakan dan menjaga kerahasiaan data Peserta pada Aplikasi e-PLKK, sebagaimana bentuk pakta integritas yang tercantum dalam Lampiran V Perjanjian Kerja Sama ini dan memberitahukan secara tertulis

- apabila terdapat pergantian user **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
- j. melakukan pemasangan logo PLKK dan media informasi terkait **PIHAK PERTAMA** di tempat strategis;
 - k. mengganti kerugian yang timbul atas terjadinya kecurangan yang disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** atau petugas yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**;
 - l. menyediakan sistem antrean, jadwal tindakan medis operatif dan informasi ketersediaan ruang perawatan rawat inap biasa dan ruang perawatan ICU yang dapat diakses oleh Peserta dan **PIHAK PERTAMA**;
 - m. menyediakan informasi isi rekam medis yang paling sedikit terdiri atas identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, pengobatan dan rencana tindak lanjut Pelayanan Kesehatan, nama dan tanda tangan tenaga kesehatan pemberi Pelayanan Kesehatan. Dalam hal dibutuhkan untuk menindaklanjuti hasil audit dan/atau verifikasi paska klaim, **PIHAK KEDUA** mengizinkan untuk melihat rekam medis pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - n. menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal terdapat perubahan dokumen yang menjadi persyaratan mutlak kerja sama (Izin Operasional/Izin Usaha, Surat Izin Praktik, Sertifikat Akreditasi) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya dokumen perubahan atau sejak diterimanya dokumen perubahan tersebut oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ... sampai dengan tanggal ... **(maksimal jangka waktu 1 (satu) tahun)**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 KERAHASIAAN DAN KEAMANAN

- (1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini bersifat rahasia dan merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaannya, kecuali:
 - a. telah disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** pemberi informasi;
 - b. informasi dan data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi;
 - c. harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan wajib segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya; dan
 - d. berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memanfaatkan informasi dan data yang diperoleh dari masing-masing pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan

apapun kecuali yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga serta tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 11

PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN DAN MONEY LAUNDERING

- (1) Demi terjaganya kondusifitas selama bekerja sama serta mendukung penerapan sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan ISO 37001:2016, maka dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan sebagai berikut:
- tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - tidak akan memberikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya kerja sama; dan
 - menjamin proses kerja sama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing pihak di dalamnya.
- (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak lainnya berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak.

PASAL 12

PEMBERITAHUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan surat menyurat atau pemberitahuan yang perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

SANKSI

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila:
- melanggar/tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama;
 - terlambat melakukan pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan lebih dari 1 (satu) bulan;
 - PIHAK KEDUA** terbukti melakukan pelanggaran ketentuan kerahasiaan pada Perjanjian Kerja Sama ini;
 - petugas **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KEDUA** melakukan tindakan yang merusak citra **PIHAK PERTAMA**; dan/atau
 - memungut biaya tambahan kepada Peserta diluar ketentuan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mekanisme sebagai berikut:
- dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK PERTAMA** memberikan teguran dengan

mengirimkan surat peringatan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui adanya pelanggaran oleh **PIHAK KEDUA**.

- b. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat peringatan pertama diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** tidak memberikan tanggapan dan tidak ada perbaikan, maka **PIHAK PERTAMA** memberikan teguran dengan mengirimkan surat peringatan kedua.
 - c. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat peringatan kedua diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** tidak memberikan tanggapan dan tidak ada perbaikan maka **PIHAK PERTAMA** menindaklanjuti dengan pemutusan Perjanjian Kerja Sama dan meminta penggantian terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh **PIHAK KEDUA** apabila ada.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** atau petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan kecurangan yang merugikan **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** menindaklanjuti dengan pemutusan perjanjian kerjasama dan meminta penggantian terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh **PIHAK KEDUA** apabila ada.
- (4) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** terlambat melakukan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan yang telah dinyatakan lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** memberikan teguran dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat peringatan pertama kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu pembayaran yang telah ditentukan.
 - b. jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat peringatan pertama diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** masih belum melakukan pembayaran maka **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat peringatan kedua.
 - c. jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat peringatan kedua diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** belum melakukan pembayaran tagihan, maka **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat pemberitahuan penghentian sementara pemberian Pelayanan Kesehatan kepada Peserta **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** kembali memberikan Pelayanan Kesehatan setelah **PIHAK PERTAMA** melunasi tagihan biaya Pelayanan Kesehatan yang telah dinyatakan lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 14

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling lama setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan administratif dan operasional sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. kepatuhan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. sarana dan prasarana; dan

d. kualitas pelayanan.

PASAL 15
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini. *Force Majeure* tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah berdasarkan surat pemberitahuan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat atau pihak yang berwenang yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau perlu dilakukan perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dilakukan perubahan atau tambahan (adendum) dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri **(sesuai lokasi pihak pertama).**

PASAL 18

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena hal-hal sebagai berikut:
- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. dikehendaki oleh salah satu Pihak dan disetujui Pihak lainnya; atau
 - c. pengakhiran sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Terhadap pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. **PIHAK** yang menginginkan pengakhiran wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki;
 - b. **PIHAK** yang menerima permintaan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama wajib memberikan jawaban terhadap pengajuan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan tertulis diterima; dan
 - c. dalam hal **PIHAK** yang menerima permintaan pengakhiran tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, permintaan pengakhiran dianggap disetujui.
- (3) Pengakhiran Perjanjian sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan atas kehendak **PIHAK PERTAMA** dalam hal:
- a. **PIHAK KEDUA** melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan telah mendapat surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dari **PIHAK PERTAMA** namun tidak ada tanggapan dan tidak ada perbaikan;
 - b. **PIHAK KEDUA** melakukan kecurangan;
 - c. **PIHAK KEDUA** melakukan malpraktik;
 - d. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi standar kredensialing yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
 - e. **PIHAK KEDUA** terbukti melanggar pernyataan anti korupsi, penyuapan, dan *money laundering*; dan/atau
 - f. **PIHAK KEDUA** berada dalam keadaan pailit berdasarkan keputusan pengadilan.
- (4) Pengakhiran Perjanjian ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 19
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai *copy* untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA
(NAMA FASILITAS KESEHATAN)

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG

(NAMA)
(JABATAN)

(NAMA)
KEPALA KANTOR CABANG

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor: PER/ ... /... (nomor pihak pertama)

Nomor: ... (nomor pihak kedua)

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

I. PELAYANAN MEDIS

1. Pelayanan medis kepada peserta **PIHAK PERTAMA** dapat diberikan oleh Dokter Spesialis/Sub Spesialis dengan tarif ... (pilih salah satu: 1. Tarif INA-CBGs yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau 2. Tarif paket tindakan atau 3. Tarif Fee for services yang setara tarif kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah.... (nama) atau tarif Rumah Sakit Pemerintah Daerah...(nama) di Provinsi setempat).
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan ruang perawatan kelas ..., (bagi rumah sakit pemerintah kelas 1 dan bagi rumah sakit swasta setara rumah sakit pemerintah kelas 1 provinsi setempat sebagaimana pasal 5 ayat 2) dan apabila tidak tersedia kelas yang ditentukan maka Peserta dilayani di ruang perawatan 1 tingkat lebih tinggi sampai dengan ruang perawatan kelas yang seharusnya tersedia kembali. Penagihan biaya ruang perawatan yang lebih tinggi ditagihkan berdasarkan tarif kelas perawatan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama dan selisih biaya yang timbul akibat tidak tersedia kelas yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, Peserta, keluarga Peserta, dan/atau Pemberi Kerja.
3. Dalam hal ruang perawatan kelas ... sebagaimana angka 2 belum tersedia lebih dari 7 (tujuh) hari sejak Peserta di rawat inap maka Peserta diberikan pilihan:
 - a. dirawat 1 kelas lebih rendah; atau
 - b. dirujuk ke PLKK lain.
4. Penagihan biaya ruang perawatan yang lebih rendah sesuai dengan angka 3 huruf a ditagihkan sesuai ruang kelas perawatan yang digunakan oleh Peserta.
5. Dalam hal Peserta dan/atau Pemberi Kerja menginginkan kelas perawatan lebih tinggi dari kelas yang telah ditentukan maka Peserta/keluarga Peserta dan/atau Pemberi Kerja harus menandatangani surat pernyataan dari Rumah Sakit dan selisih biaya menjadi tanggung jawab Peserta/keluarga Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
6. Lama hari rawat inap dihitung dari selisih antara tanggal pulang/tanggal keluar rumah sakit (kondisi hidup atau meninggal dunia) dengan tanggal masuk rumah sakit.
7. Dalam hal Peserta diberikan Pelayanan Kesehatan di ruang rawat inap yang masuk dan keluar pada hari yang sama maka dihitung 1 (satu) hari.

II. ALUR PELAYANAN

PIHAK KEDUA memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta Program JKK yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK melalui prosedur pelayanan sebagai berikut:

1. Peserta datang berobat dengan menunjukkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau KTP.
2. Petugas **PIHAK KEDUA** meneliti Eligibilitas Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK melalui Aplikasi e-PLKK di *website* BPJS Ketenagakerjaan (alamat *website*: <https://e-plkk.bpjsketenagakerjaan.go.id/login.bpjs>) dan/atau kemudian menghubungi petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan konfirmasi apabila diperlukan.
3. Dalam hal penyampaian Laporan tahap I dilakukan oleh Pemberi Kerja melalui **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1. Untuk Peserta Penerima Upah, pemberi kerja menyampaikan laporan tahap I kepada **PIHAK PERTAMA** melalui **PIHAK KEDUA** dengan sarana:
 - a. bagi Pemberi kerja merupakan pengguna Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) maka pemberi kerja mengisi e-formulir KK tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir Penyakit Akibat Kerja tahap I (Form 3 PAK 1) pada SIPP dan dilengkapi dengan dokumen pendukung pengajuan tahap I; atau
 - b. bagi Pemberi kerja bukan merupakan pengguna Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) maka pemberi kerja mengisi dan menyerahkan formulir KK tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir Penyakit Akibat Kerja tahap I (Form 3 PAK 1) yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung pengajuan tahap I.
 - 3.2. Untuk Peserta Bukan Penerima Upah, Peserta/pihak keluarga mengisi dan menyerahkan formulir kecelakaan kerja tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir Penyakit Akibat Kerja tahap I (Form 3 PAK 1) yang telah dilengkapi dengan dokumen pengajuan tahap I.
 - 3.3. Untuk Peserta Jasa Konstruksi, Pemberi Kerja/Perusahaan Jasa Konstruksi membuat pelaporan Kecelakaan kerja dengan mengisi dan menyerahkan formulir Kecelakaan Kerja tahap I (Form 3 KK 1) dan melengkapi dokumen pengajuan tahap I.
4. **PIHAK KEDUA** memastikan Pemberi Kerja/Peserta/keluarga Peserta mengisi dan menyerahkan surat pernyataan bersedia menanggung biaya perawatan dan pengobatan yang tidak ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. **PIHAK KEDUA** mengisi uraian Kecelakaan Kerja/data PAK untuk Peserta PU dan BPU dengan melampirkan dokumen pendukung dalam Aplikasi e-PLKK sebagai dokumen pengajuan SKP kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. Dalam hal Peserta merupakan Peserta Jasa Konstruksi atau Peserta Pekerja Migran Indonesia maka **PIHAK KEDUA** mengisi uraian Kecelakaan Kerja/PAK secara manual dan menyampaikannya beserta dokumen pendukung kepada **PIHAK PERTAMA**.

7. **PIHAK PERTAMA** melakukan Verifikasi/pemeriksaan terhadap formulir pengajuan SKP dari **PIHAK KEDUA** dan menerbitkan SKP paling lambat 2 (dua) hari **kerja** melalui Aplikasi e-PLKK.
8. **PIHAK KEDUA** memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai indikasi medis, dalam hal Peserta memerlukan tindakan operatif/pemeriksaan khusus maka petugas **PIHAK KEDUA** wajib melakukan konfirmasi kepada Petugas **PIHAK PERTAMA**.
9. Dokter **PIHAK KEDUA** yang merawat Peserta wajib mengisi formulir 3b KK 3 untuk kasus Kecelakaan Kerja atau formulir 3b PAK 3 untuk kasus Penyakit Akibat Kerja jika perawatan dan pengobatan dinyatakan selesai dengan status kondisi akhir sembuh, cacat, atau meninggal dunia;
10. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan jasa pengangkutan berupa pelayanan ambulans untuk menjemput dan/atau mengantar Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau PAK di lokasi kerja ke rumah sakit dan /atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada Kecelakaan Kerja/PAK, dan rujukan ke rumah sakit lain.
11. Penggantian biaya pelayanan ambulans sesuai dengan tarif kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama.

III. PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN

1. Pemberian resep obat-obatan oleh dokter yang memeriksa atau dokter yang menangani di **PIHAK KEDUA** bagi Peserta Program JKK mengutamakan obat Generik dan Formularium Nasional.
2. Harga obat dan alat kesehatan menggunakan patokan Harga Netto Apotek ditambah ppn dan biaya pelayanan kefarmasian.... % dari harga tersebut. **(Kepala Kantor Cabang dan KBL bertanggung jawab penuh mengutamakan negosiasi seefisien mungkin dengan paling tinggi yang dapat disepakati 30%)**
3. Untuk harga obat dan alat kesehatan lebih dari Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) menggunakan patokan harga netto ditambah ppn dengan biaya pelayanan kefarmasian ... %. **(Kepala Kantor Cabang dan KBL bertanggung jawab penuh mengutamakan negosiasi seefisien mungkin dengan paling tinggi yang dapat disepakati 20%)**

IV. RUJUKAN

Dalam hal Peserta memerlukan penanganan di PLKK yang lebih lengkap dan/atau alasan lain dengan persetujuan dokter yang merawat, **PIHAK KEDUA** dapat merujuk Peserta ke PLKK lainnya dengan melaksanakan prosedur sebagai berikut:

1. Peserta mendapatkan persetujuan untuk dirujuk ke PLKK lain dari dokter yang merawat;
2. **PIHAK KEDUA** melakukan penginputan e-formulir rujukan dalam Aplikasi e-PLKK dan memilih PLKK tujuan rujukan bagi Peserta PU dan BPU. Bagi Peserta Jasa Konstruksi dan Peserta Pekerja Migran Indonesia mengisi dan mengirimkan formulir rujukan secara manual kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK KEDUA** menginformasikan adanya rujukan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk Peserta Jasa Konstruksi dan Peserta Pekerja Migran Indonesia;

4. **PIHAK PERTAMA** melakukan pemeriksaan e-formulir/formulir rujukan dan berkoordinasi dengan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan PLKK rujukan;
5. Dalam hal Peserta layak dirujuk ke PLKK lain, **PIHAK PERTAMA** melakukan persetujuan rujukan dan mengirimkan pemberitahuan ke PLKK tujuan rujukan; dan
6. Dalam hal PLKK rujukan menerima Peserta, PLKK penerima rujukan memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan indikasi medis Peserta.

V. KATEGORI PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis program JKK yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta program JKK meliputi:

1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
2. Perawatan tingkat pertama dan Perawatan lanjutan;
3. Rawat inap;
4. Penunjang diagnostik
5. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan kerja dan PAK;
6. Perawatan intensif;
7. Pelayanan khusus;
8. Alat kesehatan dan implan;
9. Jasa dokter/medis;
10. Operasi;
11. Pelayanan darah;
12. Rehabilitasi medik;
13. Perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan/atau
14. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus PAK.

VI. PERAWATAN DI RUMAH (HOME CARE) * (apabila **PIHAK KEDUA** memiliki fasilitas home care, apabila tidak ada angka VI ini dihapus)

1. Manfaat *Home Care* diberikan kepada Peserta dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1.1. Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau PAK yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena keterbatasan fisik dan/atau kondisi geografis;
 - 1.2. adanya rekomendasi dokter pemeriksa dari **PIHAK KEDUA** dan/atau dokter penasihat; dan
 - 1.3. adanya persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
2. *Home Care* untuk Peserta dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Manfaat *Home Care* meliputi tindakan medis dan asuhan keperawatan sesuai standar *Home Care*.
4. Tindakan medis dan asuhan keperawatan sebagai berikut:
 - 4.1. perawatan luka seperti *debridement* atau irigasi luka, pembalutan luka, pengkajian dan pengambilan kultur luka, monitoring perkembangan penyembuhan luka, dan mengajarkan keluarga tentang perawatan luka di rumah;

- 4.2. perawatan pasien dengan gangguan sistem pernapasan seperti pengisapan atau *suction* lendir, manajemen terapi oksigen, manajemen ventilasi mekanik, dan perawatan *tracheostomy*;
 - 4.3. perawatan pasien dengan gangguan eliminasi seperti irigasi dan perawatan kolostomi, mengajarkan pasien dan keluarganya tentang cara menggunakan peralatan seperti pispot, urinal, perawatan kateter urin, dan observasi adanya tanda-tanda infeksi;
 - 4.4. perawatan pasien dengan gangguan nutrisi seperti memberi makan melalui NGT, mengajarkan keluarga tentang cara memberikan makanan, mengkaji status nutrisi pasien, dan memberikan petunjuk pelaksanaan diet;
 - 4.5. kegiatan rehabilitasi seperti mengajarkan keluarga tentang cara menggunakan alat bantu, melakukan latihan fisik, ambulasi dan tehnik pemindahan pasien;
 - 4.6. pelaksanaan pengobatan seperti memberi petunjuk dan membimbing pasien dan keluarganya tentang cara pemberian obat, cara kerja dan efek samping obat serta tindakan yang harus dilakukan; dan
 - 4.7. kolaborasi pemberian terapi intravena seperti pengkajian dan penatalaksanaan hidrasi, pemberian antibiotik, pemberian nutrisi parenteral, transfusi darah, pemberian analgetik dan chemoterapi.
5. Diberikan kepada Peserta paling lama 1 (satu) tahun sejak direkomendasikan oleh dokter pemeriksa/dokter yang merawat dan disetujui **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukan *Home Care* dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tidak termasuk biaya obat-obatan dan alat kesehatan.
 6. Pembiayaan atas obat-obatan dan alat kesehatan yang timbul untuk *Home Care* dimasukkan ke dalam tagihan biaya Pelayanan Kesehatan melalui **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
 7. Dalam hal perawatan dan pengobatan telah mencapai masa 1 (satu) tahun atau pembiayaan telah mencapai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka perawatan dan pengobatan lanjutan dilakukan di **PIHAK KEDUA**.

VII. KOMORBIDITAS DAN KOMPLIKASI

1. Komorbiditas dan komplikasi yang dapat ditanggung merupakan komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja atau PAK;
2. Komorbiditas/penyakit penyerta yang diderita oleh Peserta sebelum terjadi Kecelakaan Kerja atau PAK dapat ditanggung **PIHAK PERTAMA** saat peserta menjalani perawatan pertama di **PIHAK KEDUA**.
3. Peserta yang mengalami komplikasi atau komorbid yang mengakibatkan perburukan penyembuhan Kecelakaan Kerja atau PAK ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** hingga kondisi akhir (sembuh, cacat atau meninggal dunia) termasuk biaya pengobatan dan perawatan rujukan antar spesialis.
4. Komorbiditas dan komplikasi dijamin setelah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

VIII. PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI

- 1. Penggantian biaya administrasi rawat inap dan rawat jalan untuk biaya Pelayanan Kesehatan di **PIHAK KEDUA** mengacu pada tarif ... (tarif **PIHAK KEDUA** atau tarif rumah sakit sesuai dengan nama rumah sakit pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)) dengan ketentuan:
 - a. maksimal 3% dari keseluruhan biaya Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kunjungan rawat jalan maupun setiap periode rawat inap dan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Biaya pendaftaran untuk setiap kunjungan rawat jalan maupun setiap periode rawat inap mengacu pada tarif Rumah Sakit Pemerintah ... (sesuai dengan nama rumah sakit pemerintah provinsi setempat).

IX. HAL-HAL YANG TIDAK DITANGGUNG

PIHAK PERTAMA tidak menanggung biaya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta apabila termasuk dalam kategori sebagai berikut:

- 1. penyakit akibat hubungan kerja (*work related diseases*) yaitu penyakit yang dicetuskan atau diperberat oleh pekerjaan atau lingkungan kerja;
- 2. tindakan mencelakakan diri sendiri yang dilakukan secara sengaja;
- 3. obat yang mengandung ekstrak tumbuhan atau hewan, atau vitamin yang tidak sesuai dengan indikasi medis;
- 4. tindakan operasi dan obat-obat kosmetik yang bertujuan untuk estetik;
- 5. pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
- 6. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
- 7. Pelayanan Kesehatan rujukan ke luar negeri; atau
- 8. kategori lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA
(NAMA FASILITAS KESEHATAN)

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG

(NAMA)
(JABATAN)

(NAMA)
KEPALA KANTOR CABANG

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor: PER/ ... /.... (nomor pihak pertama)
Nomor: (nomor pihak kedua)

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

- I. Tarif pelayanan/perawatan sesuai berita acara negosiasi yaitu (Berisi lampiran tarif yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2))

(Contoh:

Rawat Jalan

Dokter Umum (UGD)	Rp
Dokter Spesialis	Rp
Dokter subspesialis	Rp
Pemeriksaan Penunjang	Rp
Laboratorium	Rp
Radiologi	Rp
Tindakan medis	Rp
.....	
.....	

Rawat Inap

Kamar rawat inap	Rp
Operasi kecil	Rp
Operasi sedang	Rp
Operasi besar	Rp
.....	
.....	

Biaya administrasi rawat inap maksimal 3% dari keseluruhan biaya pelayanan kesehatan dan paling banyak sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap periode rawat inap.

Biaya pendaftaran	Rp
Administrasi rawat jalan	Rp
(mengacu pada tarif Rumah Sakit Pemerintah setempat)	

Ambulans	Rp)
----------	-----

- II. Tarif Pelayanan medis operatif/Tindakan operatif kondisi tertentu.
- Perhitungan tarif pada pelayanan medis operatif/tindakan operasi diklasifikasikan menjadi beberapa hal berikut:
1. Dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih tindakan medis operatif (bukan kasus *fragmentasi*) dimana operator dengan spesialisasi berbeda lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan terhadap pasien yang sama, paket tindakan operatif utama dihitung 100 % atau sesuai tarif, demikian juga untuk

- operator yang kedua dan untuk tindakan anestesi dihitung (maksimal 40% (empat puluh persen)) dari jasa pelayanan operator tertinggi. (contoh : bedah orthopedi dengan bedah urologi).
2. Dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih tindakan medis operatif (bukan kasus fragmentasi), dilakukan oleh 1 (satu) operator dalam waktu bersamaan pada pasien yang sama, paket tindakan operatif utama dihitung 100 % atau sesuai tarif, sedangkan untuk tindakan operatif kedua dan seterusnya pada lokasi tubuh yang sama dikenakan ...% (Kepala Kantor Cabang dan KBL bertanggung jawab penuh mengutamakan negosiasi seefisien mungkin dengan paling tinggi yang dapat disepakati 60%) dari tarif tindakan yang dimaksud. Apabila tindakan operatif kedua dan seterusnya pada lokasi tubuh yang berbeda dikenakan ...% (Kepala Kantor Cabang dan KBL bertanggung jawab penuh mengutamakan negosiasi seefisien mungkin dengan paling tinggi yang dapat disepakati 80%) dari tarif tindakan yang dimaksud
 3. Pada tindakan medis operatif ulang yang berhubungan dengan operasi pertama dan dilakukan dalam masa satu periode perawatan, maka diatur:
 - a. reoperatif ke-1 (kesatu) dikenakan tarif tindakan medis operatif ...% (Kepala Kantor Cabang dan KBL bertanggung jawab penuh mengutamakan negosiasi seefisien mungkin dengan paling tinggi yang dapat disepakati 75%); dan
 - b. reoperatif ke-2 (kedua) dan ketiga, dikenakan tarif tindakan medis operatif% (Kepala Kantor Cabang dan KBL bertanggung jawab penuh mengutamakan negosiasi seefisien mungkin dengan paling tinggi yang dapat disepakati 50%).
 - c. reoperatif selanjutnya dibebaskan dari jasa operasi.
 4. Tindakan medis operatif yang menggunakan atau didampingi oleh dokter ahli/spesialis pendamping lain (non bedah), tarif untuk dokter ahli/spesialis pendamping adalah...% (Kepala Kantor Cabang dan KBL bertanggung jawab penuh mengutamakan negosiasi seefisien mungkin dengan paling tinggi yang dapat disepakati 20%) dari jasa pelayanan operator. (Contoh: Operasi tulang belakang yang dilakukan oleh dokter orthopedi dan didampingi oleh dokter neurologi.)

III. Penggolongan Tindakan operasi

1. Operasi cito adalah tindakan bedah yang harus segera dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasien untuk mendapatkan hasil optimal bagi keselamatan pasien, dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) jam sejak pasien di asesmen oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).
2. (pilih salah satu)
(bagi rumah sakit yang memiliki tarif cito)
Tarif tindakan cito adalah tarif jasa pelayanan operator dan anestesi tindakan medis operatif terencana ditambah dengan ...% (besaran persentase tarif dinegosiasikan oleh-Kepala Kantor Cabang dan KBL yang bertanggung jawab penuh mengutamakan negosiasi seefisien mungkin dengan paling tinggi yang dapat disepakati 30% dari biaya operasi terencana) dari Tarif jasa pelayanan operator dan anestesi tindakan medis operasi terencana sesuai pengelompokannya
Atau

(bagi rumah sakit yang tidak memiliki tarif cito)

Tarif Tindakan cito adalah sebesar biaya operasi terencana.

3. Setiap tindakan operatif melampirkan salinan hasil laporan operasi yang minimal memuat :
- 3.1. jenis dan tindakan operatif;

3.2. diagnosa penyakit;

3.3. tanggal dan waktu tindakan operatif;

3.4. jumlah dan nama dokter yang melakukan operatif;

3.5. ringkasan tindakan operatif; dan

3.6. kesulitan dan komplikasi yang mungkin terjadi selama tindakan operatif.
4. Daftar pengelompokan tindakan operatif orthopedi sebagai berikut:

PENGGOLONGAN TINDAKAN OPERATIF ORTHOPEDI

I. KNEE

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
1	SEDANG II	Tindakan dilakukan dengan anestesi local
2	SEDANG III	Closed Reduction knee
3	BESAR I	Open Reduction knee
4	BESAR III	ORIF
5	KHUSUS I	1. ORIF Advance 2. Arthroscopy Diagnostic 3. Open knee debridement 4. Arthroscopy debridement knee 5. Arthroscopy remove loose body 6. Arthroscopy Meniscectomy 7. Arthroscopy Synevectomy knee
6	KHUSUS II	1. Arthroscopy meniscus repair 2. Microfracture 3. Single ligament reconstruction of the knee 4. Primary total Knee Replacement 5. Autogenous Chondrocyte Implantation 6. Osteotomy around the knee (HTO/DFO)
7	KHUSUS III	1. I Revisi TKR 2. Difficulty primary total knee replacement 3. Multiligament reconstruction of the knee 4. Ligament reconstruction + meniscus/cartilage repair

II. SPINE

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT - TINDAKAN
1	SEDANG II	1. Mayor degloving, wound debridement and repair of the spine 2. Plaster application of extremity & spine 3. Traction application of the spine
2	SEDANG III	1. Biopsy Vertebra (1 level) 2. Manipulation & reduction of simple fracture and dislocation with general anaesthesia. 3. Body cast / Halo vest / Minerva application

3	BESAR I	1. Discograph (1 level)
4	BESAR II	1. Removal of Implants (plate, nail, screw) 2. Discograph (Mult ilevel)
5	BESAR III	1. IDET 1(1 level) 2. Open Disectomy (1 level) 3. Thermal Disc 4. Facet Block 5. Radiofrequency 6. CESI 7. Foraminal Block / Selective nerve root block 8. Percutaneous Laser Disc Decompression (PLDD) 9. Stem cells injection to the spine 10. Secretome injection to the spine
6	KHUSUS I	1. Debridement in spinal infection without stabilization 2. Open reduction of spinal fracture/dislocation without stabilization 3. Posterolateral fusion / alar transverse fusion 4. Endoscopic decompression of nerve root / spinal cord (1 level) 5. Microscopic Decompression (1 level) 6. Laminectomy (1 level) in simple spine stenosis 7. Open disectomy multilevel 8. IDET multilevel 9. Vertebroplasty 10. Kyphoplasty 11. Acromial dc score level 12. ACCF / ACDF single level 13. Open door laminoplasty without instrumentation 14. Exploration and Repair of Nerve and/or spinal cord injury
7	KHUSUS II	1. Debridement spinal infection + anterior/posterior stabilization 2. Open reduction of spinal fracture + stabilization 3. Posterolateral fusion / alar transverse fusion + stabilization 4. Anterior disectomy for correction of scoliosis 5. Open door laminoplasty + instrumentation 6. Microscopic Decompression (Multi level) 7. Endoscopic decompression of nerve root / spinal cord (Multi level) 8. Lumbar interbody fusion (Posterior (PLIF), Anterior (ALIF), Oblique (OLIF), Lateral (XLIF)) 9. Total Disc Replacement (1 level) 10. Anterior decompression thoracic + thoracotomy 11. Decompression dengan score > 2 level 12. ACCF / ACDF (Multi level) 13. Thoracoscopy
8	KHUSUS III	1. Anterior and Posterior surgery in spinal disease / deformity with stabilization / instrumentation 2. Debridement in infection case of the spine + anterior and posterior stabilization 3. Scoliosis correction surgery (Idiopathic, Congenital, Neuromuscular, Degenerative) 4. Endoscopic decompression of nerve root / spinal cord with instrumentation/stabilization 5. Spinal osteotomy for ankylosing spondylitis 6. Lumbar interbody fusion (Posterior (PLIF), Anterior (ALIF), Oblique (OLIF), Lateral (XLIF)) + anterior/posterior stabilization 7. Total Disc Replacement (Multi level)

		8. Deformity correction 9. Decompression + miss dengan score
--	--	---

III. TRAUMA

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
1	KECIL	1. Tindakan dilakukan dengan anestesi local 2. External Fixation Wire/Schanz Pin (Only) Revision and/or Removal 3. Screw (only) removal/Revision (i.e syndesmotic screw, removal of interlocking screw for dynamization) 4. Secondary /Delayed Primary Suturing of wounds
2	SEDANG	1. Debridement of Wound (without Fracture) 2. Removal of External Fixation (without Conversion to other fixation) 3. Antibiotic Bone Spacer/Beads Insertion or Exchange (without fixation / revision of fixation) 4. Bone Graft insertion (without fixation or revision of fixation) 5. Skin graft (Full or Split Thickness) 6. Manipulation of Joints Under Anesthesia 7. Fasciotomy for Compartment syndrome or other diagnosis (without fixation) 8. Local Skin Flap for wound closure (without fracture)
3	BESAR	1. Fixation of Simple Extraarticular Fracture (internal fixation, external fixation) 2. Closed Reduction +/- Circular Cast / Splint 3. Temporary Fixation by external fixation (for Damage Control Orthopedics/Part of Staged Fixation) 4. Debridement of Open Fracture +/- temporary external fixation 5. Debridement of Osteomyelitis/Infected Fracture (without Fixation / revision of fixation) 6. Amputation (primary / revision) 7. Arthrodesis 8. Removal of Hardware 9. Joint contracture release
4	KHUSUS I	1. Fixation of Multiple Extraarticular Fracture 2. Fixation of Complex Extraarticular Fracture (Proximal Femur, Comminuted diaphyseal, Bone Loss, Neglected, etc) 3. Intraarticular/Periarticular Fracture Fixation (other than Acetabular Fracture) 4. Revision Surgery (Internal Fixation/External Fixation/Other) of Extrarticular Fracture 5. Flap (Pedicled/Regional for Soft Tissue Defects of the Limb (without bone procedure) 6. Corrective Osteotomy 7. Debridement of Osteomyelitis/Fracture Related Infection (with Fixation/Revision of Fixation) 8. Osseointegration procedure for Amputation 9. Distraction Arthroplasty 10. Limb Lengthening 11. Conversion to Internal Fixation after Bone Lengthening/Transport

5	KHUSUS II	1. Fixation of Pelvis and Acetabular Fracture 2. Fixation of Intraarticular Fracture with Ligament Repair or Reconstruction 3. Fixation of Multiple Intraarticular Fracture 4. Revision Surgery (Internal Fixation/External Fixation/Other) of Intraarticular Fracture 5. Fixation of Fracture combined with Soft Tissue Coverage procedure (Regional Flap and/or Skin Graft) 6. Critical-Sized Bone Defect Reconstruction (Distraction Osteogenesis, Masquelet, Vascularized Bone Graft.) without soft tissue procedure 7. Flap (Free-Flap) for Soft Tissue Defects of the Limb (without bone procedure)
6	KHUSUS III	1. Revision of Pelvis and Acetabular Fracture 2. Critical-sized Bone Defect Reconstruction (Distraction Osteogenesis, masquelet, Vascularized Bone Graft, etc) with Soft Tissue Procedure (Flap, Tendon Lengthening, Release, etc) 3. Fixation of Fracture combined with Soft Tissue Coverage procedure (Free Flap) 4. Joint Replacement (for Intraarticular Fracture, Periarticular Nonunion/Malunions, and/or Muskuloskeletal Infection) 5. Megaprosthesis/Endoprosthesis (for Severe Fracture, periarticular bone defects and/or Muskuloskeletal Infection)

IV. HAND

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
1	KECIL	Tindakan dilakukan dengan anestesi local
2	SEDANG III	1. Angkat K-wire tanpa anesthesia/ regional 2. Tendon sheath & Jaringan subkutis, ganglion /small bursa, excision 3. Sendi (Extremitas atas) Rush rods/wires/screws removal 4. Nail bed, laceration, repair (single)
3	BESAR I	1. Tendon – extensor (extremitas atas) injury, repair (single) 2. Tendon Sheath (extremitas atas), tenosynovitis (single) , drainage 3. Jari, injury, degridement 4. Jari, Superficial infection, drainage 5. Jari, wart /corn/naevus, excision 6. Jari, various, amputasi (single) 7. Jari, deep infection, drainage 8. Jari, extra digit, amputasi 9. Jari, crush injury (simple), wound debridement 10. Tendon sheath (extremitas atas) ganglion/ villo nodular synovitis excision 11. Tendon Sheath (extremitas atas), trigger jari (single) release
4	BESAR II	1. Jari, scar, revision Osteotomy 2. Jari /Digit, Stump, revision 3. Nail Bed, laceration, repair (multiple) 4. Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle 5. Jari, Jaringan lunak tumor, excision 6. Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/ entrapment, pulley rekonstruksi 7. Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple) , drainage 8. endon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple) ,

		drainage 9. Carpus, fracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna 10. Jari, crush injuries (complex) wound debridement
5	BESAR III	1. Tendon (Ekstremitas atas) contracture , tenotomy 2. Kulit dan jaringan subkutis , Laceration (Superficial) of more than 7 cm, repair 3. Sendi (jari), various lesions, arthrodesis
6	KHUSUS I	1. Nerve, Various lesions, biopsy 2. Kulit dan jaringan subkutis , Defect (Single digit) , Free full thicckness graft 3. Jari, various lesions, Ray amputasi (Single) 4. Nerve (Ekstremitas atas) , Entrapment syndrome (others) , decompression (unilateral) 5. Nerve (Ekstremitas atas) , Entrapment syndrome (others) , decompression (unilateral) 6. Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release (unilateral) 7. Tendon sheath (ekstremitas atas) , De Quervain's (unilateral), release 8. Tendon Sheath (ekstremitas atas), trigger jari (Multiple), release 9. Jari, Defect/ contracture (single) rekonstruksi 10. Jari, trauma, terminalisation (single) 11. Jari, Closed fracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single) 12. Jaringan lunak (palmar space) abscess, drainage 13. Jari, Defect/ contracture (multiple) rekonstruksi 14. Jari, ring constriction (single), koreksi 15. Jari, trauma, terminalisation (single) 16. Jari, Deformities, osteotomy 17. Tendon - flexor (Ekstremitas atas) injury, tendon graft 18. Tendon - flexor (Ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (multiple) 19. Nerve (Ekstremitas atas) , carpal tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis) 20. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), Decompression (Bilateral) 21. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), Decompression with nerve transposition /endoneurolysis 22. Nerve (Ekstremitas atas), guyon's Tunnel syndrome, release bilateral with endoneurolysis) 23. Tendon sheath (ekstremitas atas), De quarvain's (Bilateral), release 24. Thumb, deformities, koreksi 25. Jari, tumors, Excision with disecction of neurovascular bundle 26. Carpus, Delayed / Non union, rekonstruksi 27. Jari, ring constriction (multiple), koreksi 28. Jari, Syndactyly (multiple) 29. Tendon - flexor (ekstremitas atas), adhesion, tenolysis (multiple) 30. Tendon – flexor (ekstremitas atas) , Defect grafting (single)
6	KHUSUS II	1. Nerve digital, injury, Microsurgical (single) 2. Nerve ulnar, entrapment, transposition 3. Elbow , tennis elbow, release 4. Elbow (Medial epicondyle) , fracture , excision bony fragment 5. Jari, various lesions, amputasi (multiple) 6. Artery, large, Injury, repair with grafting 7. Sendi (wrist), Various lesions, Arthrodesis 8. Nerve-Digital, injury, microsurgical repair (multiple) 9. Nerve (ekstremitas atas), major, injury, microsurgical, repair (single)

		10. Thumb, paralysis, opponens plasty 11. Jari, deformity, instrinsic muscle release / transfer / extensor relocation 12. Jari, deformities, major reconsructive procedure 13. Jari, fracture / dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple) 14. Head-face, trauma, craniofacial approach reduction dan fixation 15. Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty
7	KHUSUS III	1. Kulit dan jaringan subkutis, defect (Deep) staged distant flap (Division) 2. Kulit dan jaringan subkutis, defect (Multiple digits) staged local flap (Division) 3. Kulit dan jaringan subkutis, defect (Deep) staged distant flap (division) 4. Nerve defect, peripheral graft 5. Nerve various lesions, primary / secondary suture 6. Jari, Swan neck/ Boutonniere deformity (single), koreksi 7. Jari, deformities, Koreksi 8. Jari, Syndactyly (single) Koreksi 9. Jari, polydactyly, amputasi with rekonstruksi 10. Sendi (jari), contracture, capsulectomy / capsulotomy 11. Nerve digital, injury, primary repair 12. Jari, Macrodactyly, debulking

V. HIP

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
1	SEDANG II	Tindakan dilakukan dengan anestesi local
2	SEDANG III	Closed reduction hip
3	BESAR I	Open reduction hip
4	BESAR II	ORIF
5	BESAR III	1. Hip arthroscopy diagnostic 2. Debridement
6	KHUSUS I	1. Advance ORIF 2. Simple Arthroscopy HiD 3. Hip Arthroscopy CAM Osteoplasty 4. Pincer resection 5. Subimpingement Resection 6. Gluteus tendon repair / snapping hip 7. Hamstring repair/reconstruction
7	KHUSUS II	1. Hemiarthoplasty 2. Advance Arthroscopy Hip 3. Primary Total Hip Replacement (THR) 4. ORIF with minimal invasive 5. Core decompression 6. Osteotomy around the hip 7. Single ligament reconstruction of the hip 8. Hip arthroscopy labral repair 9. Varus/ valgus derotational osteotomy
8	KHUSUS III	1. Revisi THR 2. Dificulty Primary total hip replacement 3. Multiligament reconstruction of the hip 4. Hip arthroscopy labral reconstruction 5. Ligamentum teres reconstruction 6. Periacetbular osteotomy 7. Arthroplasty Jari 8. Arthroscopy

		9. Tendon Transfer 10.FFMT
--	--	-------------------------------

VI. SPORT INJURY

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
1	KHUSUS I	1. Diagnostic: Arthroscopic (Knee) 2. Debridement: Arthroscopic (Knee) 3. Cartilage Defect Treatment 4. Microfracture : Arthroscopic 5. Lateral Release (combine) : Knee Arthroscopic and open surgery 6. Knee Arthrofibrosis release 7. Diagnostic : Arthroscopic (Ankle) 8. Debridement: Arthroscopic (Ankle) 9. Ankle Peroneal Tendon Repair 10. Management of Plantar Fasciitis (Arthroscopic) 11. Cartilage Problem in Ankle Treatment 12. Calcified Tendinosis Removal (Shoulder) 13. Management of Elbow Tendinosis 14. Tennis Elbow Release 15. Loose Body Removal: Arthroscopic (Elbow) 16. Diagnostic: Arthroscopic (Hip) 17. Debridement: Arthroscopic (Hip)
2	KHUSUS II	1. Colletral Ligament Reconstruction (Knee) 2. Meniscus Repair : Arthroscopic 3. Discoid Menicus Treatment 4. Arthroscopic Assisted Internal Fixation (Knee) 5. Postero Lateral Corner Reconstruction 6. Management of Ankle Impingement: Arthroscopic 7. Sinus Tarsi Syndrome 8. Management of Achilles Problem 9. Management of Impingement Syndrome (Shoulder) 10. Open Rotator Cuff Repair 11. Repair Rotator Cuff Tears (Mini Open) 12. Biceps Tendon Repair and Tenodesis 13. Frozen Shoulder Treatment 14. Anterior – Inferior Instability : Open Repair 15. Adhesive Capsulitis Relase (Shoulder) 16. Arcomioclavicular Joint Treatment 17. Elbow Contracture Release: Arthroscopic 18. Wrist Sports Injury 19. TFCC Injury 20. Loose Body Removal: Arthroscopic (Hip) 21. Femoral Acetabular Impingement Management: Arthroscopic 22. Hip Extraarticular Management

3	KHUSUS III	1. ACL Reconstruction (single or double Bundle) : Arthroscopic 2. ACL Reconstruction Adolescence: Arthroscopic 3. PCL Reconstruction: Arthroscopic 4. Multi Ligament Reconstruction (Knee) 5. Revision of Ligament Reconstruction (Knee) 6. Meniscus Transplant 7. Terapi Sel : Sports Injury Related (Knee) 8. MPFL Reconstruction (combine): Arthroscopic and open surgery 9. Chondrocyte Replantation: Arthroscopic (Knee) 10. Patella Instability Treatment 11. Sports related Osteotomy (Knee) 12. Management of Ankle Instability 13. Shoulder Instability Treatment 14. Arthroscopic Rotator Cuff Repair 15. Management of Irreparable Rotator Cuff Tears 16. Superior Labrum Anterior Posterior Lesion Repair (Shoulder) 17. Shoulder Anterior and Anteroinferior Instability : Arthroscopic Repair 18. Shoulder Posterior Instability Treatment 19. Shoulder Multi-Directional Instability Treatment 20. Management of Elbow Instability 21. Labrum Repair: Arthroscopic 22. Stem cells and Tissue Engineering
---	------------	--

VII. FOOT AND ANKLE

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
1	KECIL	Tindakan dilakukan dengan anestesi local
2	SEDANG	1. Injeksi intraarticular / intralesi tanpa guiding 2. Closed reduction untuk dislokasi sendi
3	BESAR I	1. Debridement terbuka 2. Release hammer toe (single) 3. Biopsi eksisi 4. Injeksi intraarticular dengan image guiding 5. Implant removal (simple) 6. Amputasi toes / disartikulasi IP, MTP joint 7. Ostectomy 8. Morton neuroma decompression / excision
4	BESAR II	1. Implant removal (dengan penyulit) 2. Arthrotomy debridement 3. Release tarsal tunnel 4. Release hemmer toe (multiple) 5. Amputasi ray, midfoot, hindfoot, ankle 6. Closed reduction + internal fixation 7. ORIF / CRIF fraktur forefoot 8. Tendon lengthening 9. Plantar fasciotomy 10. Syndesmosis fixation

5	KHUSUS I	1. Open repair Achilles tendon 2. Gastrocnemius recession 3. Osteotomy calcaneus 4. Arthroscopy diagnostik 5. Arthroscopy removal loose bodies 6. Tendon repair 7. Percutaneous pinning pada foot/ankle joint 8. Calcaneoplasty untuk Achilles tendinopathy 9. Open reduction untuk dislokasi sendi 10. ORIF fraktur ankle malleolus / bimalleolar 11. Cheilectomy 12. Peroneal retinaculum repair 13. Midfoot reconstruction (termasuk Lisfranc joint) 14. Release Baxter nerve entrapment
6	KHUSUS II	1. Arthroscopy foot/ankle capsular release 2. Percutaneous repair Achilles tendon 3. Hallux valgus reconstruction 4. Flat feet primary reconstruction 5. Arthroereisis 6. Foot/ankle joint arthrodesis 7. ORIF intraarticular ankle joint dengan LCP 8. Diabetic foot reconstruction 9. Single stage deformity correction 10. Achilles tendon reconstruction 11. Tendon transfer 12. Arthroscopic treatment for ankle impingement 13. Open ligament repair / reconstruction 14. ORIF fraktur midfoot, hindfoot 15. ORIF fraktur trimalleolar 16. Open technique for osteochondral lesion treatment 17. Plantar plate repair 18. Peroneal groove deepening 19. Weil osteotomy 20. Arthroscopy hindfoot, subtalar, forefoot 21. Endoscoipy tendon, tendon sheath, sinus tarsi
7	KHUSUS III	1. Total ankle replacement 2. Revisi total ankle replacement 3. Supramalleolar osteotomy 4. Hallux valgus reconstruction dengan prosedur tambahan 5. Flat foot / Pes cavovarus reconstruction 6. Gradual deformity correction dengan Ilizarov technique 7. Distraction arthroplasty / arthrodesis dengan Ilizarov technique 8. Arthroscopy assisted internal fixation (ARIF) foot/ankle joint 9. Arthroscopy haglund resection 10. Arthroscopic ligament reconstruction / tendon transfer 11. Arthroscopic treatment for osteochondral lesion 12. Orthobiologics treatment 13. Arthrodesis multiple joints

VIII. SHOULDER AND ELBOW

NO	GOLONGAN TINDAKAN	NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
1	KECIL	Tindakan dilakukan dengan anestesi lokal
2	SEDANG	Biopsy shoulder/ elbow joint
3	BESAR I	Debridement shoulder / elbow joint

4	BESAR II	1. Percutaneous release ECRB 2. Hydrodilatation frozen shoulder
5	KHUSUS I	1. Open acromioplasty 2. ORIF Proximal humerus Neer 2 part 3. Ulnar nerve decompression +/- transposition 4. Ulnar nerve decompression +/- transposition
6	KHUSUS II	1. Suprascapular nerve block for adhesive capsulitis 2. Debridement for septic arthritis / osteomyelitis and prosthetic joint infection around shoulder and elbow joint 3. Open rotator cuff repair (<= 1 tendon) 4. ORIF proximal humerus Neer 3 part with bonegraft and PHILOS 5. ORIF distal humerus double column without olecranon osteotomy 6. Complex radial head fracture (ORIF/ resection) 7. Arthroscopic diagnostic shoulder/ elbow 8. Arthroscopic synovectomy/ remove loose body shoulder/ elbow 9. early repair of serratus anterior avulsion 10. Neurolysis of long thoracic nerve
7	KHUSUS III	1. Transtendineous rotator cuff repair 2. Single row arthroscopic rotator cuff repair 3. Transosseus equivalent/ suture bridge repair of rotator cuff-arthroscopy 4. Margin convergence repair in large massive rotator cuff repair 5. Muscle sliding repair in retracted rotator cuff repair 6. Superior capsular reconstruction fascia lata for massive cuff tear 7. LHB capsular reconstruction for massive cuff tear 8. Arthroscopy rotator cuff repair with augmentation 9. Arthroscopic subacromial decompression 10. Arthroscopic subcoracoid decompression 11. Arthroscopy biceps tenodesis/ tenotomy 12. Mini open subpectoral tenodesis 13. Arthroscopy rotator interval release 14. Arthroscopy 360 degree capsular release in adhesive capsulitis 15. Latissimus dorsi transfer for posterior superior cuff deficiency 16. Lower trapezius transfer for external rotation deficit of shoulder 17. Pectoralis major transfer for anterior superior cuff deficiency 18. Reverse shoulder arthroplasty for massive rotator cuff tear 19. Graft reconstruction for late pectoralis major rupture 20. Pectoralis major transfer for late deltoid rupture 21. Arthroscopic decompression for snapping scapula syndrome 22. Muscle transfer for scapular winging 23. Scapulothoracic fusion 24. AC Joint ligament reconstruction open / arthroscopy 25. Pectoralis major repair/ reconstruction for pectoralis major rupture 26. Latissimus dorsi repair/ reconstruction for latissimus dorsi rupture 27. Eden Hybinete for anterior recurrent shoulder dislocation 28. Glenoid bone reconstruction for anterior recurrent shoulder dislocation (open/ arthroscopy) 29. Arthroscopy capsulolabral repair for shoulder instability 30. Arthroscopic bony bankart repair 31. Arthroscopic posterior labral repair 32. Arthroscopic SLAP repair 33. Arthroscopy capsular plication for multidirectional instability 34. Arthroscopic remplissage for hillsach lesion 35. Reverse Mclaughlin/ iliac crest bone graft to humeral head for posterior recurrent shoulder dislocation (open/arthroscopy) 36. Complex fracture of acromion

	37. Complex fracture of scapular (open)/ revision 38. Complex fracture of proximal humerus 39. Hemiarthroplasty for 4 part proximal humerus fracture 40. Total/Reverse shoulder arthroplasty for 4 part proximal humerus fracture 41. Arthroscopic ECRB release for lateral epicondylitis 42. Medial collateral ligament reconstruction of elbow 43. Lateral collateral ligament reconstruction of elbow 44. Triceps tendon repair/reconstruction 45. Distal biceps tendon repair, button/ anchor, single/double incision 46. Ancones interposition arthroplasty for lateral compartment OA 47. Reconstruction elbow for stiff elbow and unreduced dislocation 48. Arthroscopy release lateral / medial epicondylitis Arthroscopic assisted for intraarticular fracture of elbow 49. Terrible triad of elbow 50. Complex intra articular distal humeral fracture with olecranon osteotomy 51. Radial head arthroplasty for complex radial head fracture 52. Total elbow arthroplasty for complex fracture 53. Elbow interpositional arthroplasty Arthrosopic of osteochondritis dissecans of elbow
--	---

III. Berita Acara Negosiasi

Berita Acara Negosiasi ini digunakan untuk negosiasi ketentuan tarif sebelum dilakukan perjanjian kerja sama atau adendum perjanjian kerja sama. Bentuk Berita Acara Negosiasi Tarif Kerja Sama adalah sebagai berikut:

BERITA ACARA
NEGOSIASI TARIF KERJA SAMA
NOMOR : BA/.../...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... (DD-MM-YYYY) pukul WIB, antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang ... dengan ... telah diadakan negosiasi harga Tarif Kerja Sama tahun ... sesuai penawaran dari ... tanggal ... bulan... tahun... sesuai terlampir :

Hasil negosiasi tersebut diatas disetujui ... dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang...serta ditandatangani oleh yang berhak dan mewakili dibawah ini.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fasilitas Kesehatan

(.....) (.....)
(jabatan) (jabatan)

SAKSI

1. nama : **(saksi PIHAK PERTAMA)**
jabatan
2. nama : **(saksi PIHAK KEDUA)**
jabatan

PIHAK KEDUA
(NAMA FASILITAS KESEHATAN)

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG

(NAMA)

(JABATAN)

(NAMA)
KEPALA KANTOR CABANG

LAMPIRAN III
PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor: PER/ ... /... (nomor pihak pertama)

Nomor: ... (nomor pihak kedua)

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TAGIHAN
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

I. Tata Cara Pengajuan Tagihan Biaya Pelayanan Kesehatan

1. Dokumen kelengkapan pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. Kartu Peserta;
 - b. KTP atau Passport bagi Warga Negara Asing;
 - c. surat pengajuan tagihan pembayaran yang ditandatangani oleh pimpinan **PIHAK KEDUA** atau Pihak dari **PIHAK KEDUA** yang diberikan kewenangan beserta rincian tagihan biaya Pelayanan Kesehatan;
 - d. SKP;
 - e. kuitansi bermeterai cukup atau kuitansi digital elektronik;
 - f. bukti pembayaran iuran terakhir bulan berjalan **PIHAK KEDUA** atas kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. Dalam hal Peserta telah dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia persyaratan sebagaimana angka 1 ditambahkan surat keterangan dokter kasus kecelakaan kerja atau surat keterangan dokter kasus PAK (Formulir 3b KK 3 untuk kasus Kecelakaan Kerja atau formulir 3b PAK 3 untuk kasus PAK)
3. Selain dokumen sebagaimana angka 1 dan angka 2 di atas, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta dokumen antara lain:
 - a. Hasil penunjang pelayanan medis;
 - b. Laporan tindakan medis;
 - c. resume medis Peserta;
 - d. formulir Kecelakaan Kerja tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir Penyakit Akibat Kerja tahap I (Form 3 PAK 1) apabila disampaikan melalui **PIHAK KEDUA**; dan/atau
 - e. surat rujukan antar PLKK yang digunakan sebelumnya.
4. Dalam hal pengajuan tagihan dilakukan secara daring, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tetap disampaikan secara fisik kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK PERTAMA** melakukan proses Verifikasi berkas klaim paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap yang dibuktikan dengan dokumen penyampaian informasi kelengkapan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal hasil Verifikasi menyatakan dokumen telah sesuai dan benar maka pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dokumen terverifikasi dibuktikan dengan lembar hasil Verifikasi;

- b. dalam hal hasil verifikasi menyatakan dokumen tidak sesuai maka **PIHAK PERTAMA** menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penyesuaian dokumen tagihan;
- c. penyesuaian dokumen tagihan sebagaimana dimaksud huruf b disampaikan kembali kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) hari kerja;
- d. dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melakukan penyesuaian dan tidak menyampaikan kembali dokumen tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf c maka **PIHAK PERTAMA** mengembalikan dokumen tagihan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- e. dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diajukan kembali bersamaan dengan pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan pada bulan berikutnya dengan ketentuan tidak melewati kadaluarsa klaim.

II. Pengajuan Tagihan Biaya Pelayanan Kesehatan COB dengan PT. Jasa Raharja (Persero) dan asuransi lain.

1. Dalam hal Peserta mengalami Kecelakaan Kerja di lalu lintas yang memenuhi syarat dan ruang lingkup penjaminan PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai perjamin pertama yang dibuktikan dengan surat jaminan Jasa Raharja maka **PIHAK KEDUA** menagihkan kelebihan biaya dari plafon yang dijamin oleh PT. Jasa Raharja (Persero) kepada **PIHAK PERTAMA** dengan persyaratan pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan/atau angka 3 bagian I lampiran III ini.
2. Dalam hal kasus penjaminan dilakukan oleh asuransi lain maka selisih biaya yang tidak ditanggung oleh asuransi tersebut dapat diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan/atau angka 3 bagian I lampiran III ini ditambahkan dengan surat keterangan dari asuransi lain dimaksud yang telah melakukan penjaminan pertama.

III. Tata Cara Pembayaran

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran atas tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan lembar hasil verifikasi **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam hal batas waktu pembayaran klaim sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
3. Pembayaran dilakukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 Nama Rekening :.....
 nomor rekening : ...
 Bank :.....
 Cabang :.....
4. Biaya transfer yang timbul atas pembayaran tagihan dimaksud menjadi tanggung jawab (**PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA** berdasarkan hasil negosiasi).

5. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan surat pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan beserta bukti bayar, rincian pembayaran beserta keterangan selisih pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.

IV. Rekonsiliasi Tagihan

Rekonsiliasi tagihan dilakukan oleh **PARA PIHAK** setiap bulan untuk melakukan pencocokan data, transaksi dan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan dokumen dan data yang ada pada **PARA PIHAK** agar terjadi sinkronisasi antar entitas pelaporan di masing-masing Pihak dalam hal pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian hak dan kewajiban yang timbul dari pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan.

Bentuk Berita Acara Rekonsiliasi sebagai berikut:

**BERITA ACARA
REKONSILIASI TAGIHAN
NOMOR : BA/.../...**

Pada hari ini tanggal....., bulan....., tahun, BPJS Ketenagakerjaan melakukan rekonsiliasi klaim tagihan biaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, periode bulan sd, Tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Bulan Kasus Kejadian KK/PAK	Bulan pengajuan klaim	Jumlah Pengajuan (Rp)	Hasil Verifikasi (Rp)	Selisih Jumlah yang dibayarkan (Rp)	Keterangan (Jika ada Selisih Pembayaran)

Demikian berita acara rekonsiliasi dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan

Pihak Rumah Sakit

(nama kepala kantor cabang)
(.....)
Jabatan :
Jabatan :

V. Dokumen Penyampaian Informasi Kelengkapan dokumen Tagihan Biaya Pelayanan Kesehatan

INFORMASI KELENGKAPAN DOKUMEN TAGIHAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : .../.../...

Pada hari ini tanggal....., bulan....., tahun, Rumah Sakit, mengajukan tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang, untuk klaim bulan pelayanan, Tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Jumlah Kasus Pengajuan**	Dokumen Lengkap (Kasus)	Dokumen tidak Lengkap (Kasus)	Keterangan
UGD				
Rawat Jalan				
Rawat Inap				
Perawatan lainnya				
Jumlah				

Dokumen lengkap akan dilakukan verifikasi oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen yang tidak lengkapkasus, untuk dapat dilengkapi paling lambathari.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan

Pihak Rumah Sakit

(nama kepala kantor cabang)

(.....)

Jabatan :

Jabatan :

** detail nama pasien terlampir

PIHAK KEDUA
(NAMA FASILITAS KESEHATAN)

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG

(NAMA)
(JABATAN)

(NAMA)
KEPALA KANTOR CABANG

LAMPIRAN IV
PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor: PER/ ... /.... (nomor pihak pertama)
Nomor: (nomor pihak kedua)

BENTUK PAKTA INTEGRITAS PLKK

PAKTA INTEGRITAS
(Nama PLKK)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kepala Rumah Sakit ...

NO	NAMA	NIK	NO. TELP	ALAMAT EMAIL YANG VALID	MASA PENUGASAN	
					TMT	TAT

2. Petugas penanggung jawab pada Aplikasi e-PLKK sebagai berikut:

NO	NAMA	NIK	NO. TELP	ALAMAT EMAIL YANG VALID	MASA PENUGASAN	
					TMT	TAT

3. Petugas penganggung jawab administrasi sebagai narahubung BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	NIK	NO. TELP	ALAMAT EMAIL YANG VALID	MASA PENUGASAN	
					TMT	TAT

Dengan ini menyatakan bahwa:

a. Dalam menggunakan *user login* untuk melakukan entri data pada Aplikasi e-PLKK akan menjaga kerahasiaan dan tidak memiliki niat dan/atau melakukan tindakan untuk kepentingan pribadi atau tujuan melakukan sesuatu untuk manfaat sendiri, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait serta tidak memiliki potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan diatas.

b. Dalam waktu 1x24 jam akan melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan apabila terdapat pergantian petugas entri baik dikarenakan pindah tugas maupun adanya putus hubungan kerja.

c. Berkomitmen untuk melakukan pekerjaan secara profesional atas dasar kejujuran dan bertanggung-jawab terhadap hasil pekerjaan yang telah disepakati dengan BPJS Ketenagakerjaan

d. Melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan.

e. Berkomitmen menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain.

f. Pakta integritas ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun dan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya nyatakan di sini. Demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara hukum apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Demikian Pakta Integritas ini kami tanda tangani untuk digunakan sebagaimana mestinya.
....., 20...

KEPALA/PIMPINAN/DIREKTUR	PENANGGUNGJAWAB USER	PENANGGUNGJAWAB NARAHUBUNG
--------------------------	-------------------------	-------------------------------

<u>NAMA LENGKAP</u> JABATAN	<u>NAMA LENGKAP</u> JABATAN	<u>NAMA LENGKAP</u> JABATAN
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

*) TMT: Terhitung Masuk Tanggal
*) TAT: Terhitung Akhir Tanggal

PIHAK KEDUA
(NAMA FASILITAS KESEHATAN)

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG

(NAMA)
(JABATAN)

(NAMA)
KEPALA KANTOR CABANG

LAMPIRAN V
PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor: PER/ ... /.... (nomor pihak pertama)
Nomor: (nomor pihak kedua)

ADMINISTRASI SURAT MENYURAT

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	
BPJS Ketenagakerjaan	Alamat Kantor -----	
.....	Alamat web : (apabila ada)	
Alamat Kantor	Nomor Telp/faks	
.....	Petugas yang dapat dihubungi	
Alamat web :	(PIC)	
www.bpjsketenagakerjaan.go.id	1. PIC Administrasi	
		2. PIC Klinis
Nomor Telp/faks	Jabatan	
.....		Jabatan
Petugas yang dapat dihubungi	No HP	
(PIC)		No HP
Jabatan.....		
No HP :	Alamat email	
Alamat email :		Alamat email

PIHAK

PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG

(NAMA)
KEPALA KANTOR CABANG

PIHAK KEDUA
(NAMA FASILITAS KESEHATAN)

(NAMA)
(JABATAN)

NO	Uraian	JATIM	
		PROVINSI JAWA TIMUR (KANWIL)	
		All Kacab	
		PEMERINTAH	SWASTA
I	Jasa dokter		
1	Dokter Umum/UGD		
2	Dokter spesialis		
3	Dokter subspesialis		
II	UGD		
1	Dokter UGD		
2	RESUSITASI		
3	Observasi di UGD < 2 Jam		
4	Observasi di UGD > 2 Jam < 6 Jam		
5	Observasi > 6 Jam		
III	RAWAT INAP		
1	visite dr sp		
2	visite dr subspesialis		
3	telemedicine dr sp		
4	telemedicine dr umum		
5	telemedicine dr sp subspesialis		
6	Rawat inap		
7	HCU		
8	ICU/ICCU		
9	isolasi		
10	intermediete		
IV	Homecare		
1	homecare 12 jam		
2	homecare 24 jam		
3	homecare 8 jam		
4	perawatan luka homecare		
5	homevisite dokter umum		
6	homevisite dr spesialis		
7	homevisite perawat/terapis/analisis		
8	Jasa dokter		
9	Jasa perawat		
10	Jasa rehab		
11	Tindakan sederhana		

12	Tindakan sedang		
V	Laboratorium		
1	Darah rutin		
2	Darah lengkap		
3	SGOT		
4	SGPT		
5	HBsAG		
6	anti HBS		
7	HIV		
8	anti HIV penyaring		
9	Masa perdarahan		
10	Masa pembekuan		
11	Ureum		
12	albumin		
13	analisa gas darah		
14	asam urat darah		
15	calcium darah		
16	bilirubin		
17	kholesterol HDL		
18	LDL		
19	total		
20	Kreatinin		
21	glucosa 2 jam PP		
22	glucosa puasa		
23	glukosa sewaktu		
24	protein		
25	trigliserida		
26	urin rutin		
27	Rapid antigen Covid		
VI	RADIOLOGI		
1	Rontgen kepala		
2	Clavikula		
3	Torax		
4	Femur		
5	Tibia cruris		
6	Pelvis		
7	Lumbal		
8	hip joint		
9	abdomen polos		
10	angkle		
11	antebrachi		
12	shoulder		

13	cervical		
14	genu		
15	humerus		
16	manus		
17	pelvis		
18	pedis		
19	TMJ		
20	rahang		
21	digiti		
22	vertebrae		
23	c-arm		
24	c-arm dengan kontras		
VII	USG		
1	abdomen atas/bawah/lengkap		
2	digiti		
3	manus		
4	pergelangan tangan/kaki		
5	pedis/genu		
6	bahu		
7	thorax		
VIII	MRI		
IX	CT scan		
X	EKG		
XI	REHABILITASI MEDIS		
1	TMS		
2	Evaluasi kapasitas fungsional return to work --> Manajemen rehabilitasi interdisiplin ?		
3	Pengukuran, Fitting, Revisi Orthosis dan Sepatu		
4	Peresepan dan Check Out Orthosis, alat bantu jalan, dan alat imobilisasi sendi (casting, splinting)		
5	Peresepan dan Check Out Prosthesis		
6	Rehabilitasi psikososial, lingkungan, rumah, dan hambatan kerja; Rehabilitasi paliatif; Tatalaksana perawat rehabilitasi		

7	Rehabilitasi vokasional dan okupasi		
8	Terapi Latihan Lingkup Gerak Sendi Ekstremitas		
9	Terapi Latihan menggunakan ortosis, prostesis, dan alat bantu jalan		
10	Terapi Latihan Penguatan Otot		
11	Terapi Latihan Peregangan		
12	Terapi Modalitas : TENS, ES, PTNS, NMES, Tapping Straping		
13	Terapi Modalitas Diatermi: US, MWD, SWD		
14	Terapi Modalitas Dingin (Ice Massage/ Vapocoolant spray)		
15	Terapi Modalitas Panas Superfisial: Parafin Bath, IRR		
16	Terapi Modalitas Traksi		
17	Uji Fungsi Kekuatan Otot menggunakan alat		
18	Uji Fungsi Persepsi, Uji Fungsi Kognisi		
19	Uji Kemampuan Fungsional (Menelan, Sensori integrasi, Sensori taktil dan proprioseptif, Komunikasi, Motorik halus anak, Fungsi tangan, Kardiorespirasi, Spirometri, AKS, Vokasional, Uji Fungsi Berkemih)		
20	Uji Kontrol Gerak (Fungsi Eksekusi/Praksis, Lokomotor, Keseimbangan, Pola Jalan)		
XII	paket rawat inap		
	Sewa kamar		
XIII	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF		
1	ps infus		
2	aff infus		
3	ps kateter		
4	aff kateter		
5	injeksi sub cutan		
6	injeksi IV/IM		

7	ambil darah / AGD		
8	angkat drain		
9	NGT		
10	Clisma		
11	suction		
12	transfusi darah		
13	memberikan transfusi		
14	syringe pump		
15	perawatan luka ringan		
16	perawatan luka sedang		
17	perawatan luka berat		
18	defibrilator		
19	Aff Arch Bar + Wire		
20	pasang gips 2'		
21	pasang gips 4'		
22	pasang gips 6'		
23	pasang perban		
24	buka gips		
25	ganti perban		
26	pasang spalk		
27	debridement luka besar (>11 cm)		
28	debridement luka kecil (<5 cm)		
29	debridement luka sedang (6-10 cm)		
30	hecting <10 simpul		
31	hecting >10 simpul		
32	STSG/skin graft		
33	STSG tanpa benang		
34	potong flap		
35	nekrotomi dan pasang/ganti perban		
36	Pemasangan Gips atas lutut tanpa reposisi		
37	Pemasangan Gips bawah lutut tanpa reposisi		
38	Pemasangan Gips atas siku tanpa reposisi		
39	Pemasangan Gips bawah siku tanpa reposisi		
40	Rawat luka terbuka besar (>11 cm)		
41	Rawat luka terbuka sedang (6 cm - 10 cm)		
42	Rawat luka terbuka kecil (< 5 cm)		

43	Reposisi dan pemasangan gips atas lutut / siku dengan lokal anestesi		
44	Reposisi dan pemasangan gips bawah lutut/siku dengan lokal anestesi		
45	Rozer plasty		
46	Skin Traction		
47	Strapping		
48	Perawatan Luka Bakar dengan sedasi		
49	Perawatan Luka bakar di wajah		
50	Perawatan Luka Bakar tanpa sedasi dengan atau tanpa STSG		
51	Thakheostomy		
52	WSD		
53	Excisional Debridement / Nekrotomi/ Eskarektomi (kategori tindakan disamakan)		
XIV	TINDAKAN OPERATIF		
	Jasa dr BEDAH		
1	Kecil		
2	sedang I		
3	Sedang II		
4	sedang III		
5	besar I		
6	besar II		
7	besar III		
8	khusus I		
9	khusus II		
10	khusus III		
	Jasa dr Anestesi		
1	Kecil		
2	sedang I		
3	sedang II		
4	sedang III		
5	besar I		
6	besar II		
7	besar III		
8	khusus I		
9	khusus II		
10	khusus III		

	Sewa kamar OK		
1	Kecil		
2	sedang I		
3	sedang II		
4	sedang III		
5	besar I		
6	besar II		
7	besar III		
8	khusus I		
9	khusus II		
10	khusus III		
	Sewa Alat OK		
1	Kecil		
2	sedang I		
3	sedang II		
4	sedang III		
5	besar I		
6	besar II		
7	besar III		
8	khusus I		
9	khusus II		
10	khusus III		
XV	ADMINISTRASI		
	rawat jalan/UGD		
	rawat inap		



SALINAN
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA DAN PENGAJUAN PEMBAYARAN DARI
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Kerja Sama dan Pengajuan Pembayaran dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 338);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAN PENGAJUAN PEMBAYARAN DARI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
3. Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disingkat PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
4. Kasus adalah kejadian Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sarana yang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau swasta.
6. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
7. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
8. Kredensialing adalah penilaian penyelenggaraan pelayanan program jaminan kecelakaan kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk mengetahui standar layanan yang tersedia, kapasitas, dan kualitas calon mitra yang akan bekerja sama dan mitra yang telah bekerja sama.

BAB II TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 2

- (1) BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja, PAK, dugaan Kecelakaan Kerja dan/atau PAK bekerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. klinik;
 - d. rumah sakit; dan
 - e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara komprehensif sesuai kebutuhan medis berdasarkan cakupan layanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut.
- (4) Pelayanan kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan Kerja Sama

Pasal 3

- (1) Kerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi BPJS Ketenagakerjaan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami Kecelakaan Kerja, PAK, atau dugaan Kecelakaan Kerja/PAK.
- (3) Sebelum melakukan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan untuk praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan meliputi:
 1. telah memiliki surat izin praktik;
 2. telah teregistrasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. telah memiliki nomor pokok wajib pajak;
 4. telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan patuh membayar iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pekerja praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan telah terdaftar sebagai Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. persyaratan untuk pusat kesehatan masyarakat meliputi:
1. telah memiliki surat izin operasional;
 2. telah memiliki sertifikat akreditasi;
 3. telah teregistrasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 4. telah memiliki surat izin praktik bagi tenaga medis yang menangani Kecelakaan Kerja dan/atau PAK;
 5. telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan patuh membayar iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pekerja pusat kesehatan masyarakat telah terdaftar sebagai Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- c. persyaratan untuk klinik meliputi:
1. telah memiliki surat izin operasional;
 2. telah teregistrasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. telah telah memiliki surat izin praktik bagi tenaga medis yang menangani Kecelakaan Kerja dan/atau PAK;
 4. telah memiliki nomor pokok wajib pajak;
 5. telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan patuh membayar iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pekerja klinik telah terdaftar sebagai Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- d. persyaratan untuk rumah sakit meliputi:
1. telah memiliki surat izin operasional;
 2. telah memiliki sertifikat akreditasi;
 3. telah teregistrasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. telah memiliki surat izin praktik bagi tenaga medis yang menangani Kecelakaan Kerja dan/atau PAK;
 5. telah memiliki nomor pokok wajib pajak;
 6. telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan patuh membayar iuran;
 7. pekerja rumah sakit telah terdaftar sebagai Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. mampu memberikan layanan rehabilitasi medik berupa layanan fisioterapi dan/atau layanan okupasi terapi,
- e. persyaratan untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang meliputi:
1. telah memiliki surat izin operasional;
 2. telah teregistrasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. telah memiliki surat izin praktik bagi tenaga medis yang menangani Kecelakaan Kerja dan/atau PAK;
 4. telah memiliki nomor pokok wajib pajak;
 5. telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan patuh membayar iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pekerja fasilitas pelayanan kesehatan penunjang telah terdaftar sebagai Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 4

- (1) BPJS ketenagakerjaan sebelum melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan kajian pembentukan kerja sama.
- (2) Kajian pembentukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. analisis pembentukan kerja sama dengan mempertimbangkan faktor yang terdiri dari:
 1. kebutuhan Peserta yang akan dilayani; dan
 2. kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
 - c. hasil Kredensialing; dan
 - d. kesimpulan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kerja sama dilakukan atas penawaran dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat jawaban berdasarkan kajian pembentukan kerja sama kepada

Fasilitas Pelayanan Kesehatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penawaran diterima.

Pasal 5

- (1) Kredensialing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi aspek sebagai berikut:
 - a. legalitas;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kredensialing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan dapat menggunakan hasil Kredensialing milik BPJS Kesehatan yang masih berlaku sebagai pertimbangan dalam bekerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Selama dalam jangka waktu kerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan Kredensialing ulang untuk memastikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tetap memenuhi standar pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Kredensialing ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Kredensialing ulang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sehubungan dengan kerja sama pelayanan Kesehatan, termasuk data tenaga pendukung atau penunjang Kesehatan pada institusi lain yang ditempatkan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemutusan Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak melaksanakan kesepakatan yang tercantum pada perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan maka BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan teguran tertulis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Apabila Fasilitas Pelayanan Kesehatan setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun tetap tidak melaksanakan kesepakatan yang

tercantum pada perjanjian kerja sama maka BPJS Ketenagakerjaan menindaklanjuti dengan:

- a. melakukan pemutusan perjanjian kerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara sepihak oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan/atau
- b. meminta penggantian terhadap kerugian yang ditimbulkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan apabila ada.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat dugaan perbuatan curang dalam penyelenggaraan kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan maka diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, organisasi profesi, ahli, dan/atau pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENAGIHAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Tagihan Dari Fasilitas Kesehatan

Pasal 10

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami Kecelakaan Kerja, PAK, dugaan Kecelakaan Kerja dan dugaan PAK berdasarkan surat kelayakan pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Surat kelayakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tindak lanjut pelaporan tahap I dari pemberi kerja atau Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan menggunakan formulir Kecelakaan Kerja tahap I yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Biaya yang timbul atas pelayanan kesehatan yang diberikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditagihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Pengajuan tagihan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atas biaya pelayanan kesehatan kepada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan 1 (satu) kali secara kolektif paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur maka Pengajuan tagihan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), batas waktu paling lambat pengajuan tagihan adalah pada hari kerja pertama berikutnya.
- (4) Biaya yang ditagihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya pelayanan pengobatan dan perawatan pada Kasus yang masih berlangsung atau telah dinyatakan sembuh/cacat/meninggal dunia oleh dokter yang merawat pada bulan berjalan.
- (5) Pengajuan tagihan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

Bagian Kedua Dokumen Persyaratan

Pasal 12

- (1) Dokumen persyaratan untuk pengajuan tagihan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:
 - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing;
 - c. surat pengajuan tagihan pembayaran;
 - d. surat kelayakan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. kuitansi bermeterai cukup atau kuitansi digital/elektronik;
 - f. bukti pembayaran iuran terakhir bulan berjalan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - g. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan dapat meminta dokumen:
 - a. hasil penunjang pemeriksaan medis;
 - b. laporan tindakan medis;
 - c. resume medis Peserta; dan/atau
 - d. surat rujukan antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang digunakan sebelumnya.
- (3) Dalam hal pengajuan tagihan dilakukan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) tetap disampaikan secara fisik kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Dokumen persyaratan yang disampaikan secara fisik kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari setelah pengajuan tagihan secara daring dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (5) Dalam hal Peserta telah dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia oleh dokter pemeriksa maka dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditambahkan dengan formulir surat keterangan dokter Kasus Kecelakaan Kerja atau surat keterangan dokter Kasus PAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dan Verifikasi

Pasal 13

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen pengajuan pembayaran dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan pembayaran diterima dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Dalam hal dokumen yang diajukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan mengembalikan berkas pengajuan pembayaran untuk dilengkapi dan diajukan kembali oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan bersamaan dengan pengajuan biaya pelayanan kesehatan bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Dalam hal dokumen yang diajukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) lengkap, BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sesuai dengan ketentuan standar tarif dan pelayanan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk melakukan penyesuaian berkas pengajuan tagihan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan penyesuaian berkas pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kembali kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak melakukan penyesuaian dan tidak menyampaikan kembali berkas pengajuan tagihan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJS Ketenagakerjaan mengembalikan berkas pengajuan tagihan yang tidak sesuai kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat mengajukan kembali berkas pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila telah disesuaikan bersamaan dengan pengajuan tagihan biaya pelayanan

kesehatan bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Bagian Keempat
Kadaluarsa Pengajuan Biaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Masa kadaluarsa pengajuan biaya pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelayanan kesehatan selesai diberikan.
- (2) Masa kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pengajuan tagihan sebagai berikut:
 - a. tagihan biaya pelayanan kesehatan yang belum ditagihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah ditagihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, namun dokumen belum lengkap dan tidak ditagihkan kembali kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. tagihan biaya pelayanan kesehatan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil verifikasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak ditagihkan kembali ke BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal jangka waktu pengajuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui maka biaya pelayanan kesehatan tidak dapat diajukan kembali.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN TARIF BIAYA PELAYANAN
KESEHATAN

Bagian Kesatu
Pembayaran dan Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

- (1) BPJS Ketenagakerjaan membayarkan tagihan Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan standar tarif dan pelayanan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen pengajuan pembayaran dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan hasil verifikasi BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 17

- (1) Tarif yang digunakan sebagai penggantian biaya pelayanan kesehatan adalah tarif pelayanan kesehatan yang telah disepakati antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Tarif biaya pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan pembayaran biaya pelayanan kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dapat meminta rekam medis Peserta berupa ringkasan rekam medis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan untuk kepentingan audit administrasi klaim, BPJS Ketenagakerjaan dapat meminta bukti pelayanan lain yang dibutuhkan serta melihat, mencatat atau mendokumentasikan rekam medis Peserta dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan tetap menjaga kerahasiaan isi rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditemukan pada proses audit administrasi klaim maupun verifikasi setelah klaim, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan kekurangan pembayaran kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditemukan pada proses audit administrasi klaim maupun verifikasi setelah klaim, Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengembalikan kelebihan pembayaran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan dalam rangka pengawasan secara internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Biaya Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Ditanggung Oleh BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 19

- (1) BPJS Ketenagakerjaan tidak menanggung biaya pelayanan kesehatan bagi Peserta selain yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan tidak menanggung biaya pelayanan kesehatan bagi Peserta apabila termasuk dalam kategori sebagai berikut:
 - a. penyakit akibat hubungan kerja yaitu penyakit yang dicetuskan atau diperberat oleh pekerjaan atau lingkungan kerja;
 - b. tindakan mencelakakan diri sendiri yang dilakukan secara sengaja;
 - c. Kecelakaan Kerja dan PAK yang diakibatkan dari tindakan yang melanggar hukum;

- d. obat yang mengandung ekstrak tumbuhan atau hewan, atau vitamin yang tidak sesuai dengan indikasi medis;
- e. tindakan operasi dan obat-obat kosmetik yang bertujuan untuk estetik;
- f. pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
- g. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
- h. pelayanan kesehatan rujukan ke luar negeri; atau
- i. kategori lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengajuan Pembayaran Secara Elektronik

Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan pengelolaan administrasi pengajuan pembayaran dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dapat mengembangkan sistem pengelolaan klaim secara elektronik atau mengintegrasikan dengan sistem yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Dalam rangka pengembangan sistem pengelolaan klaim secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan dapat meminta dokumen kelengkapan klaim dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB V KEADAAN KAHAR

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pengajuan tagihan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau pembayaran tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam 16 ayat (2) ditentukan dalam perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan paling lama setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. persyaratan administratif dan operasional sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. kepatuhan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. kualitas pelayanan.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai keahliannya untuk melakukan pemeriksaan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan tindakan medis yang dilakukan telah sesuai dengan panduan praktik klinis Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Perjanjian kerja sama, nota kesepahaman dan/atau petunjuk teknis yang disepakati antara BPJS Ketenagakerjaan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebelum diundangkannya Peraturan Badan Ini tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Badan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
- (2) Biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Peserta sebelum diundangkannya Peraturan Badan ini, harus ditagihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan ini mulai diundangkan.
- (3) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak melakukan penagihan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka biaya pelayanan kesehatan tidak dapat ditagihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2024

DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN,

ttd.

ANGGORO EKO CAHYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2024

PLT. DIREKTUR JENDRAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 800

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

 **BPJS**
Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA
SUIRWAN